جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : رحمه حسن توفيق مصطفى
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** ناهيا
رقم البطاقة : 29312112101749 **رقم التليفون :** 01112394185 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 11-12-1993 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: رحمه حسن توفيق مصطفى
National ID: 29312112101749

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٩٣١٢١١٢١٠١٧٤٩
رقم منزل
متزوجة
سلمى
أنثى
أحمد عباس على عباس
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠٣/٠٣
١
٢٠٢٦/٠٣

DMS
معطاعيه صدر وبطن وظهرها بالصبغه

رحمه
حسن توفيق مصطفى
٥ ش نظلى منصور ش تانيا
بولاق الدكرور - الجيزه
٢٩٣١٢١١٣٦٠١٧٤٩
LQ8896329

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

mm/dd/yyyy

MDT FORM

Name:	رحمه حسن عوض محمد	MRN:	9852
Age:	33 Y	ID:	
Menopausal Status:	pre	Phone:	01112394185
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	free	Reason Of MDT:	new

Clinical Data:

BX: - [illegible] G2 with focal indeterminate DCIS

ER 80S **PR** 8/8 **HER** 2+ nc **KI67** 45

Sonomammography:

Left breast (BIRADS _5): Left UOQ malignant mass lesion and non-mass multifocal lesion as described. For histopathology correlation and CESM study is highly recommended.

Mets Workup:

CT :
Multiple left axillary lymph nodes at level I. ? No pulmonary, hepatic or osseous lesions could be

History:

CESM:
LEFT BREAST: UOQ and central (from 11 to 3 o'clock) pathologically enhancing malignant process as above described (BIRADS 6)
RIGHT BREAST: No pathological mass or non-mass enhancement (BIRADS 1).

clinically: LT breast UOQ large mass +{ small axillary LNs
T3 N1 M0
for possible [illegible] neoadj ttt

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

FOR CLIP INSERTION AND BRACKTINING FOR TUMOR BEFORE START NEOADJV AC 4 CYCLES THEN TAXOL

R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Name: رحمه حسن توفيق مصطفى **MR. :** 9852	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 33-year-old individual with a diagnosis of left breast cancer, estrogen receptor positive (ER 8/8), progesterone receptor positive (PR 8/8), HER2 negative, and Ki-67 45%. Imaging and physical examination reveal a cT3 (6 × 4 cm) mass with ipsilateral axillary lymph node involvement (N1). A clip was inserted in the tumor prior to initiation of neoadjuvant chemotherapy. The planned neoadjuvant regimen consists of four cycles of AC (doxorubicin 115 mg/m² and cyclophosphamide 1150 mg/m²) followed by 12 weekly cycles of taxol (paclitaxel) at 84 mg/m². The patient's weight is 84 kg and height 160 cm. Laboratory results and echocardiogram are pending as of 27 July 2026.

On 19 August 2026, the patient was noted to have a left breast mass measuring 6 × 4 cm with a 1 × 1 cm axillary lymph node. The neoadjuvant chemotherapy plan was reiterated as AC (115 mg/m² doxorubicin, 1150 mg/m² cyclophosphamide) plus endoxan 1150 mg, with a total of two cycles of AC and a single dose of adriamycin 115 mg/m². Zoladex was also added to the regimen.

On 9 September 2026, the physical examination confirmed the left breast mass (6 × 4 cm) and a 1 × 1 cm axillary lymph node. The chemotherapy plan remained AC (115 mg/m² doxorubicin, 1150 mg/m² cyclophosphamide) with endoxan 1150 mg and the addition of zoladex.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY

Patient Name	: الأستاذه / رحمه حسن توفيق مصطفى	Request No.	: 13005371
Patient No.	: 29312112101749	Request Date	: 09/03/2026
Path No.	: 645/26	Verification Date	: 18/03/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 32 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass, "BIRADs 5".
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 9/3/2026, at 11:22 am, Cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:
- Five fragmented grey white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- Ductal carcinoma in situ: Focal intermediate grade DCIS (Solid & cribriform pattern with comedo necrosis type).
- Perineural invasion: Absent.
- Angioinvasion: Absent.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- Focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern with comedo necrosis type).
- For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Dr. Walaa Ibrahem Ghonaim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE_PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / رحمه حسن توفيق مصطفى	Request No.	: 13005371
Patient No.	: 29312112101749	Request Date	: 09/03/2026
Path No.	: 645/26	Verification Date	: 18/03/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف رومي - مبادره
Age	: 32 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE
ROUSSY

Patient Name	: الأستاذه / رحمه حسن توفيق مصطفى	Request No.	: 13005371
Patient No.	: 29312112101749	Request Date	: 09/03/2026
Path No.	: 645/26	Verification Date	: 18/03/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 32 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass, "BIRADs 5" diagnosed Invasive duct carcinoma, Grade 2, with focal intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform patterns with comedo necrosis type).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 9/3/2026, at 11:22 am, Cold ischemia time: 20 seconds.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for; ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), Ki67 clone (30-9) & SISH.

Results:
IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Intermediate complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- SISH: Not amplified.
(Average Her2 copy No.: (1.75), Her2/CEP17 ratio: (1.52)).
- Ki67%: 45%.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Not amplified, Group V.
(Average Her2 copy No.: (1.75), Her2/CEP17 ratio: (1.52)).

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

GUSTAVE ROUSSY

Patient Name	الأستاذه / رحمه حسن توفيق مصطفى	Request No.	13005371
Patient No.	29312112101749	Request Date	09/03/2026
Path No.	645/26	Verification Date	18/03/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - مبادره
Age	32 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	.marwa mohamed youssef

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- Ki67% 45%.

- Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
- Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low): as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.
ISH groups:
The ratio is calculated and the results is interpreted as:
- Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
- Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
- Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
- Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result).

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / رحمه حسن توفيق مصطفى	Request No.	13005371
Patient No.	29312112101749	Request Date	09/03/2026
Path No	645/26	Verification Date	18/03/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - مبادره
Age	32 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- Group V (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than

Signature
Dr. Walaa Ebrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient ID: 93676	Patient Name English: Rahmah Hassan Tawfik
Age: ٣٣ سنة, ٢ شهر	2026/03/08 10:35:45 AM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 33 years old female patient with left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneous fibro glandular densities (ACR density c).
- The Left breast shows UOQ a segmental area of asymmetry and distortion with segmental suspicious microcalcifications seen measuring area about 6x4 cm
- Ultrasound revealed a large ill-defined hypoechoic mass lesion with fine internal microcalcifications and internal vascularity within at located at 1 ° clock position about 4 CFMFN and measures about 3x2.5 cm (Index lesion).
  - A non-mass heterogeneous area seen from the lesion towards the nipple with query intraductal extension
- Normal nipple/areolar complex.
- Enlarged suspicious looking axillary lymph nodes with increased cortical increased reaching about 7 mm

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): Left UOQ malignant mass lesion and non-mass multifocal lesion as described. For histopathology correlation and CESM study is highly recommended.
- Right breast (BIRADS 2): normal study.

Much obliged,
Dr. Norhan osamaMD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]